



Résumé : RFE SFAR/SFMU (avec CNGOF, Collège national des sages-femmes), 9 chapitres sur la prise en charge des urgences obstétricales en dehors d'une maternité (régulation Samu, accouchement inopiné, hémorragies, traumatismes, HTA gravidique/prééclampsie/éclampsie, menace d'accouchement prématuré, transferts in utero).
Portée : couverture complète du contenu clinique actionnable des 7 chapitres d'urgence ; les chapitres 1 (information du patient) et 9 (formation/évaluation des pratiques), de nature organisationnelle et non des gestes d'urgence, sont résumés en quelques lignes — voir texte intégral pour leur détail complet.

Méthodologie

Méthode GRADE annoncée mais littérature spécifique à ce champ peu abondante : aucun grade individuel 1+/2+/A/B/C n'est utilisé — chaque item du texte court a été coté par vote Delphi (2 tours) et, hors de très rares situations sans consensus, correspond systématiquement à un **Accord fort**. Validé au 3^e trimestre 2010.

AE

Toutes les recommandations de ce texte sont validées par vote Delphi (2 tours) — **Accord fort**, sauf de très rares situations sans consensus (non détaillées par la source). Aucun grade GRADE 1+/2+/A/B/C individuel n'est utilisé dans ce document.

1 — Information du patient (résumé)

Information orale privilégiée, complétée (non remplacée) par un support écrit ; porte sur les alternatives, bénéfices/risques, possibilité d'échec et de recours à l'AG, changements de technique, séquelles rares — personnalisée en cas de risque particulier. Chez la femme enceinte : caractéristiques de la douleur du travail, techniques disponibles, bénéfices attendus, modalités pratiques, indications/contre-indications, et information sur l'anesthésie pour césarienne (alternatives, avantages/inconvénients, recours en cas d'échec, analgésie postopératoire). Toute grossesse à risque particulier de césarienne doit être fortement incitée à une analgésie péridurale précoce.

2 — Régulation Samu et décision de transport

Thème	Détail
Numéro d'appel	Le 15 (Samu) est le seul numéro à composer pour toute urgence obstétricale extrahospitalière (hors transferts interhospitaliers).
Priorisation régulation	3 ^e trimestre ou post-partum précoce → régulation prioritaire par un médecin urgentiste. Enfant né ou accouchement en cours → départ réflexe d'une équipe Smur + régulation médicale prioritaire.
Scores d'aide à la régulation	Utilisation recommandée des scores de Malinas, SPIA et Prémat-SPIA (avant 33 SA) — leur association est recommandée pour leur complémentarité.
Orientation	Maternité adaptée au plateau technique requis ; grossesse à bas risque → maternité choisie par la patiente ; urgence vitale maternelle → maternité la plus proche quel que soit le terme.
Décision accoucher sur place vs. transporter	Repose sur l'évaluation de la rapidité de dilatation (2 touchers vaginaux à 10 min d'intervalle) ; dilatation complète + envie irrésistible de pousser → accouchement sur place.
Transport (2^e/3^e trimestre)	Décubitus latéral, ceinturée — le décubitus dorsal est proscrit. Voie veineuse périphérique systématique.

Tableau 1 — Signes évoquant une urgence gynéco-obstétricale et justifiant l'envoi d'une équipe Smur, selon le terme :

Terme	Symptômes	Diagnostics à évoquer
Post-partum (≤ 15 j)	Hémorragie	Hémorragie de la délivrance
Post-partum (≤ 15 j)	Convulsion	Éclampsie
3e trimestre	L'enfant est né	Accouchement réalisé
3e trimestre	Contraction, douleur, métrorragie, envie de pousser, perte des eaux	Accouchement imminent
3e trimestre	Antécédent de césarienne ou traumatisme majeur, douleur abdo intense, baisse des MAF	Rupture utérine



Terme	Symptômes	Diagnostics à évoquer
2e/3e trimestre	Métrorragie peu abondante noirâtre, douleur abdo intense permanente, absence de MAF	Hématome rétroplacentaire
2e/3e trimestre	Métrorragie abondante rouge avec caillots, contractions	Placenta prævia hémorragique
2e/3e trimestre	Céphalée, douleur abdo, prise de poids, nausée, trouble visuel	Prééclampsie
2e/3e trimestre	Convulsion	Éclampsie
1er trimestre	Malaise, douleur abdominale, métrorragie	Grossesse extra-utérine rompue

2 (suite) — Accouchement inopiné extrahospitalier : mécanique

Thème	Détail
Position / efforts expulsifs	Favoriser les positions d'hyperflexion des cuisses sur l'abdomen. Ne débiter les efforts expulsifs que lorsque la présentation commence à apparaître à la vulve (garantie d'une dilatation complète).
Épisiotomie	Pas d'épisiotomie systématique. Médiolatérale, au moment d'une contraction, réservée à : présentation par le siège chez une primipare, indications fœtales d'accélération de l'expulsion.
Dégagement / circulaire du cordon	Une fois la tête dégagée, vérifier un circulaire du cordon ; si serré et gênant, clamber et sectionner entre 2 pinces avant de reprendre les efforts expulsifs pour l'épaule antérieure.
Prévention de l'HPP (4 règles)	Vessie vide ; utérus vide ; utérus contracté (massage utérin + oxytocine) ; compensation volémique rapide. Le clamping précoce du cordon y participe également.
Délivrance dirigée	5 UI d'oxytocine en IVD lente à la sortie complète de l'enfant, au plus tard dans la minute suivant l'expulsion ; délivrance attendue dans les 30 min ; massage utérin répété (séquences > 15 s) jusqu'à la prise en charge en maternité.
Analgesie de l'accouchement inopiné	MEOPA inhalé possible ; infiltration locale du périnée recommandée en cas d'épisiotomie.
Accouchement par le siège	Attendre l'apparition du siège à la vulve avant les efforts expulsifs, exclusivement pendant les contractions — ne jamais tirer sur un siège. 4 gestes : épisiotomie d'indication large, faire tourner le dos en avant, manœuvre de Lovset si relèvement des bras, technique de Mauriceau si rétention de la tête dernière.
Dystocie des épaules	Le plus souvent une fausse dystocie → manœuvre de Mac Roberts.
Procidence d'un bras	Incompatible avec l'accouchement par voie basse → transport rapide en décubitus latéral sous oxygène vers la maternité la plus proche, accueil organisé au bloc opératoire obstétrical.
Procidence du cordon	Urgence vitale. Si le cordon bat : refouler la présentation (poing ou 2 doigts intravaginaux, sans comprimer le cordon), position de Trendelenburg + décubitus latéral genoux contre poitrine, tocolyse IV pour bloquer les contractions, transport le plus rapide possible.
Grossesse gémellaire	Situation à haut risque (anoxie du 2 ^e jumeau, HPP) — décision transport vs. accouchement sur place au cas par cas ; demande de renfort recommandée si accouchement hors maternité.

Prise en charge du nouveau-né en extrahospitalier

Thème	Détail
5 règles, dans l'ordre	Clamber/couper/vérifier le cordon (2 artères, 1 veine) ; prévenir l'hypothermie ; évaluer l'état clinique ; prévenir l'hypoglycémie (< 2,2 mmol/L à 30 min de vie) ; favoriser le peau-à-peau.
Section du cordon	Stérile, entre 2 clamps, à ≥ 10 cm de l'ombilic.
Lutte contre l'hypothermie	Sécher l'enfant ou utiliser un sac en polyéthylène sans séchage préalable ; toujours couvrir la tête d'un bonnet ; peau-à-peau privilégié ; décubitus latéral, liberté des VAS, surveillance rapprochée.



Thème	Détail
Évaluation clinique	Tonus, ventilation, couleur et/ou SpO ₂ , puis fréquence cardiaque (auscultation ou pouls ombilical) — le score d'Apgar n'a pas de valeur décisionnelle pour la réalisation d'un geste. Stimulation possible pour déclencher la respiration, sans jamais secouer l'enfant.
Hypoglycémie	Sérum glucosé à 10 % préférentiellement per os à la seringue si nouveau-né conscient et terme > 34 SA. Le sérum glucosé à 30 % est toujours contre-indiqué. Mise au sein recommandée si la mère le souhaite.
Nouveau-né sans signe de vie	Prise en charge selon les recommandations ILCOR ; demande de renfort recommandée.
Désobstruction des VAS	Pas de désobstruction systématique si l'enfant va bien. Si nécessaire : aspiration à dépression réglable < 150 mmHg (200 cmH ₂ O).
Ventilation / oxygénation	La qualité de la ventilation prime sur la FiO ₂ . Chez le prématuré, débiter avec une FiO ₂ de 0,30 à 0,40, objectif SpO ₂ 85-95 % (risque surtout lié à l'hyperoxie). Intubation de sauvetage orale possible sans sédation, mais une ventilation au BAVU + masque reste préférable à des tentatives d'intubation répétées et maladroites.
RCP néonatale	Massage cardiaque externe + ventilation efficace dès bradycardie < 60/min — ratio 2 ventilations pour 6 compressions thoraciques.
Certificat d'accouchement / naissance	Rédigé par le médecin ou la sage-femme ayant pratiqué l'accouchement ou sectionné le cordon ; le médecin s'assure de la déclaration à l'état civil dans les 3 jours ouvrables (4 si dimanche ou jour férié).



3 — Hémorragies du 2^e et 3^e trimestre

Thème	Détail
Étiologies principales	Hématome rétroplacentaire (HRP) et anomalies d'insertion du placenta (placenta prævia). Causes cervicales : modérées, en général après examen gynécologique ou rapport sexuel. Plus rares : rupture utérine, hémorragie de Benkiser, rupture du sinus marginal.
Régulation	Toute métrorragie chez une femme enceinte au 2 ^e /3 ^e trimestre doit être régulée par un médecin urgentiste. Interrogatoire : terme, prævia connu, HTA connue, couleur/abondance du saignement, douleurs/contractions, mouvements fœtaux. En l'absence de prævia connu, évoquer un HRP jusqu'à preuve du contraire.
Prise en charge générale	Envoi systématique d'une équipe Smur à la moindre suspicion d'HRP ou de prævia hémorragique ; décubitus latéral ; bloc opératoire/obstétricien/anesthésiste prévenus et produits sanguins disponibles dès l'arrivée ; remplissage par cristalloïdes ou amidons ayant l'AMM chez la femme enceinte (transfusion préhospitalière seulement si compatible avec un transfert rapide) ; oxygénothérapie de principe.
Placenta prævia	Toucher vaginal formellement contre-indiqué si prævia connu/suspecté. Tocolyse possible en préhospitalier si CU + transport long + saignement important (concertation obstétricien). Transport en décubitus latéral. Recherche du RCF (Doppler/cardiocotocardiographe) possible sans retarder le transfert. Lieu d'accouchement = maternité la plus proche (idéalement multidisciplinaire) si prævia recouvrant hémorragique ou suspicion d'accrète.
HRP	Aucun examen ne doit retarder l'extraction fœtale si le fœtus est vivant ; transport rapide vers la maternité la plus proche que l'enfant soit vivant ou décédé.

Tableau 2 — Diagnostic différentiel placenta prævia / hématome rétroplacentaire :

	Placenta prævia	Hématome rétroplacentaire
Facteurs favorisants	Utérus cicatriciel	HTA gravidique, prééclampsie, traumatisme abdominal
Douleurs	Absentes ou peu intenses	Brutales, intenses, permanentes
Utérus	Souple, indolore en dehors des contractions	Hypertonie, hypercinésie, « utérus de bois »
Saignement	Rouge, modéré à abondant, ± caillots	Noir, peu abondant, incoagulable

4 — Hémorragie du post-partum (HPP)

Thème	Détail
Enjeu	1 ^{re} cause de mortalité maternelle en France ; plus de la moitié des décès maternels sont évitables.
Facteurs de risque	Délivrance > 30 min, âge > 35 ans, distension utérine (grossesse gémellaire), cicatrice utérine, hyperthermie per-travail, catégorie sociale défavorisée, HRP connu, placenta prævia — la majorité des HPP survient toutefois sans facteur de risque identifié.
Diagnostic / gravité	Le saignement peut atteindre 600 mL/min (sac collecteur sous les fesses pour l'évaluer). Critères de gravité : hémorragie intarissable, sang incoagulable, signes de choc. Une perte de 1000 mL peut être bien tolérée — le retentissement clinique peut être tardif et brutal, d'où une surveillance attentive systématique après tout accouchement.
Prévention (accouchement pas encore survenu)	Délivrance dirigée : 5 UI d'ocytocine IVD lente (IM à défaut) dans la minute suivant la naissance. Ne jamais tirer fermement sur le cordon pour provoquer le décollement sans formation préalable.

Fig. 1 — Algorithme de prise en charge d'une HPP extrahospitalière (retranscrit en étapes séquentielles) :

Thème	Détail
Étape 1 — délivrance non faite	Vacuité vésicale ; ocytocine 10 UI en 20 min (± bolus de 5 UI, maximum 40 UI) ; massage utérin continu.
Décollement placentaire ?	Oui → aide à l'expulsion. Non → délivrance artificielle sous anesthésie générale avec intubation.



Thème	Détail
Étape 2 — hémorragie persistante	Rechercher une atonie utérine ou une lésion de la filière génitale (examen épisiotomie/périnée/vagin) ; ocytocine (max 40 UI) ; massage utérin continu ; méchage/compression si lésion identifiée.
Possibilité de révision utérine ?	Oui → révision utérine sous anesthésie générale avec intubation. Non → transport rapide.
Sulprostone ?	Si la vacuité utérine est assurée et l'hémorragie persiste : sulprostone 100 à 500 µg/h ; arrêter les ocytociques dès son instauration ; poursuivre le massage utérin. Si opérateur non formé pour la révision utérine : transport.

Thème	Détail
Gestes endo-utérins	Délivrance artificielle et révision utérine imposent une anesthésie avec induction en séquence rapide et intubation, maintenues jusqu'à la prise en charge hospitalière spécialisée. Asepsie rigoureuse et antibioprophylaxie à large spectre systématiques.
Lésion de la filière génitale	Si l'hémorragie persiste : rechercher une lésion de l'épisiotomie, du périnée ou du vagin — méchage ou compression maintenus jusqu'à la prise en charge hospitalière.
Produits sanguins labiles	Utilisables en préhospitalier (procédures de transfusion en urgence vitale immédiate) sans retarder le transport ; acheminer les documents immuno-hématologiques avec la patiente.
Transfert interhospitalier pour HPP grave	Situation à haut risque (ex. en vue d'une embolisation) justifiant une décision réfléchie et médicalisée, concertée entre équipes obstétricale/anesthésique d'origine et receveuse, avec réévaluation du rapport bénéfice-risque au moment du départ. Un état hémodynamique instable malgré une prise en charge bien conduite est une contre-indication au transport et impose une chirurgie d'hémostase sur place, si possible conservatrice. La réparation des lésions de la filière génitale doit être réalisée avant le transfert.
HPP tardive (> 3 jours)	Douleur pelvienne + fièvre + lochies malodorantes + utérus mou non involué → évoquer une endométrite hémorragique. Retour de couches hémorragique : pas de fièvre ni douleur, utérus involué, col fermé, pertes inodores. Cause possible : placenta accreta/percreta résiduel, chute d'escarre après hystérotomie, contraception progestative microdosée. Orientation vers l'obstétricien référent, sauf urgence vitale immédiate exceptionnelle.

5 — Traumatismes chez la femme enceinte

Thème	Détail
Enjeu	La majorité des morts fœtales est évitable. Causes principales de mort fœtale : choc hémorragique maternel (80 %), décollement placentaire, mort maternelle — rarement un traumatisme direct.
Prévention	Port correct d'une ceinture de sécurité homologuée à 3 points ; son association aux airbags améliore la sécurité des femmes enceintes.
Régulation	Rechercher systématiquement : grossesse et terme, mécanisme et cinétique du traumatisme, métorragie, contractions utérines, rupture des membranes. Penser à une possible grossesse chez toute femme en âge de procréer traumatisée. Rechercher des violences domestiques si le mécanisme n'est pas évident (lésions face/thorax/abdomen).
Brûlures	Majorer les formules de compensation hydrique (surface corporelle maternelle augmentée pendant la grossesse) ; interruption de grossesse à envisager si surface corporelle brûlée > 50 %.
Intoxication oxycarbonée	Retentissement fœtal retardé, plus long et plus sévère que le retentissement maternel. Oxygénothérapie normobare impérative si symptômes ou HbCO positif, quel que soit le terme. Oxygénothérapie hyperbare systématique, organisée très précocement avec les centres d'hyperbarie et les obstétriciens.
Électrisation	Surveillance fœtale prolongée 24 à 48 h si le courant passe entre un membre supérieur et un membre inférieur (lésions fœtales possibles retardées).



Tableau 3 — Aide à la décision selon l'âge de la grossesse et l'état clinique maternel :

Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	Groupe 4
Début de grossesse ou ignorée — test de grossesse positif chez une femme en période d'activité génitale ayant eu un traumatisme grave. Prise en charge essentiellement maternelle.	Terme $\leq$ 24 SA — fœtus non viable, bien protégé par le bassin maternel (peu de lésions). Adaptation diagnostique (radios) et thérapeutique.	Terme $>$ 24 SA — fœtus viable, moins bien protégé par le bassin maternel. Prise en charge maternelle ET fœtale (monitorage, échographie, extraction prématurée ?).	Détresse maternelle ou inefficacité circulatoire — nécessité de délais très courts et problèmes éthiques. Si traitement inefficace : césarienne post-mortem ?

Thème	Détail
Monitorage	Suivre les recommandations de monitorage du traumatisé grave, en tenant compte des modifications ECG physiologiques de la grossesse (déviation axiale gauche, arythmies bénignes, ST/T, ondes Q) et de l'hémodilution physiologique pour l'interprétation de l'Hb. Cardiotocographe portable utilisable en préhospitalier — une souffrance fœtale est possible malgré un état maternel rassurant, réévaluation fréquente nécessaire.
Prévention de la compression cave	Décubitus latéral systématique à toutes les étapes jusqu'au bloc opératoire ; si la patiente ne peut être mobilisée : surélever une hanche (droite de préférence) ou récliner manuellement l'utérus vers la gauche.
Remplissage / oxygénothérapie	Débuter un remplissage précoce avant les signes cliniques d'hypovolémie (perte possible de 30-35 % de la volémie sans signe clinique). Indications d'oxygénothérapie larges (sensibilité fœtale à l'hypoxie). Respecter l'hyperventilation physiologique de la grossesse ($\text{PaCO}_2 \approx 32$ mmHg) en ventilation mécanique.
Lésions à rechercher systématiquement	Décollement placentaire (fréquent même pour un traumatisme mineur, parfois retardé de 24-48 h) ; rupture splénique (lésion hémorragique intrapéritonéale la plus fréquente) ; rupture utérine (surtout 3 ^e trimestre / traumatisme violent). Pas de toucher vaginal chez une femme enceinte traumatisée.
Analgsie	Pas de contre-indication à l'analgsie chez la femme enceinte : palier 1 = paracétamol ; palier 2 = dextropropoxyphène ; palier 3 = morphine (risques de dépression respiratoire et de sevrage néonatal si extraction). MEOPA utilisable.
Remplissage / transfusion	Cristalloïdes $\pm$ amidons ayant l'AMM chez la femme enceinte. Si transfusion de globules rouges nécessaire : concentrés érythrocytaires O rhésus négatif, si possible Kell négatif. Catécholamines en complément d'un remplissage bien conduit, malgré le risque de détournement partiel de la circulation fœtale.
Intubation trachéale	Toujours considérée comme difficile et à estomac plein. Induction en séquence rapide avec manœuvre de Sellick systématique. Voie nasotrachéale à éviter. Sondes plus petites (diamètre 5,5 à 7). Avoir à disposition et savoir utiliser rapidement une technique alternative de contrôle des voies aériennes.

6 — HTA, prééclampsie, éclampsie

Thème	Détail
Définitions	HTA gravidique : PAS $\geq$ 140 et/ou PAD $\geq$ 90 mmHg entre la 20 ^e SA et le 42 ^e jour post-partum. Prééclampsie : HTA gravidique + protéinurie $>$ 0,3 g/24 h. Prééclampsie sévère : prééclampsie + au moins un critère parmi : HTA sévère (PAS $\geq$ 160 et/ou PAD $\geq$ 110), oligurie $<$ 500 mL/24 h ou créatininémie $>$ 135 $\mu\text{mol/L}$ ou protéinurie $>$ 5 g/24 h, OAP ou barre épigastrique persistante ou HELLP, éclampsie ou troubles neurologiques persistants, thrombopénie $<$ 100 G/L, HRP, retentissement fœtal. Éclampsie : crise convulsive tonico-clonique en contexte d'HTA gravidique. HELLP : hémolyse + cytolysé hépatique + thrombopénie.
Diagnostic préhospitalier	Principalement clinique ; mesure de la PA au repos, en décubitus latéral ou en position semi-assise. L'absence d'œdème localisé ou de prise de poids brutal n'élimine pas le diagnostic.
Signes d'alerte à rechercher	HTA sévère ; signes d'éclampsie imminente (céphalées rebelles, troubles visuels, ROT polycinétiques) ; signes neurologiques évocateurs d'AVC ; signes de choc, contracture utérine, métrorragies (HRP) ; dyspnée/OAP ; douleur épigastrique (HELLP) ; oligurie/anurie.
Envoi d'équipe / orientation	Envoi rapide d'une équipe médicale recommandé si suspicion de forme sévère/compliquée. Orientation selon des critères maternels (USI obstétricale ou réanimation adulte) ET fœtaux (maternité de type adapté à l'âge gestationnel).



Thème	Détail
TIH — indications et contre-indications	Indiqué vers une maternité de type adapté si signes de sévérité/complications entre 24 et 36 SA. Contre-indications : HRP connu/suspecté, instabilité hémodynamique, HTA non contrôlée, complication systémique (OAP, éclampsie, hématome sous-capsulaire du foie) — imposent des mesures thérapeutiques sur site avant TIH ultérieur. Anomalies sévères du RCF → extraction en urgence sur place quel que soit le type de maternité (pas de TIH). Non systématique si < 24 SA (discuter une IMG) ou > 36 SA (déclenchement), mais peut se discuter.
Monitoring	FC, SpO ₂ , FR, PA non invasive, et capnométrie si ventilation mécanique — recommandés pendant toute la prise en charge préhospitalière.
Traitement antihypertenseur — seuil et titration	À débiter si PAS > 160 ou PAD > 110 mmHg. Administration par titration (voir Fig. 2). Ne pas faire descendre la PAM sous 100 mmHg ni la PAS sous 140 mmHg.

Fig. 2 — Traitement de l'HTA de la grossesse (titration) :

Seuil de PA	Conduite
PAS > 160 ou PAM > 110 mmHg	Traitement d'attaque : nicardipine 0,5-1 mg IV puis 4-7 mg en 30 min. Évaluation de l'efficacité/tolérance après 30 min.
PAS > 180 ou PAM > 140 mmHg	Traitement d'entretien : nicardipine 1-6 mg/h IV ou labétalol 5-20 mg/h IV. Réévaluation après 30 min puis chaque heure.
140 < PAS < 160 ou 100 < PAM < 120 (après traitement)	Poursuite du traitement d'entretien : nicardipine 1-6 mg/h ou labétalol 5-20 mg/h.
PAS < 140 et PAM < 100 mmHg (après traitement)	Diminution voire arrêt du traitement.
PAS > 160 ou PAM > 120 mmHg (après traitement)	Association nicardipine 6 mg/h + labétalol 5-20 mg/h (ou clonidine 15-40 µg/h si contre-indication aux bêta-bloquants).
Effets secondaires (céphalées, palpitations...)	Réduction de la nicardipine et association avec labétalol 5-20 mg/h ou clonidine 15-40 µg/h si contre-indication aux bêta-bloquants.

Thème	Détail
Expansion volémique	Possible en cas d'hypotension significative à l'instauration du traitement antihypertenseur, associée au décubitus latéral — prudente (risque d'OAP), repose sur les cristalloïdes.
Détresse respiratoire	Possible chez la patiente prééclampsique, pouvant nécessiter une intubation — risque majoré d'intubation difficile et de poussée hypertensive à l'induction, à anticiper et prévenir.
Éclampsie — traitement	Mesures générales de la crise convulsive + sulfate de magnésium 2 à 4 g IV lente puis entretien IV continu 1 g/h, + correction de l'HTA si présente. Récidive → 2 ^e dose de 1,5-2 g. Les benzodiazépines injectables et la phénytoïne sont utilisables en préhospitalier mais sont moins efficaces que le sulfate de magnésium.
Prévention primaire (prééclampsie sévère)	Sulfate de magnésium indiqué devant l'apparition de troubles neurologiques persistants (céphalées, troubles visuels, ROT polycinétiques), en l'absence de contre-indication (insuffisance rénale, pathologie neuromusculaire). Un inhibiteur calcique pour l'HTA ne doit pas retarder le sulfate de magnésium ; leur association justifie une adaptation des posologies.
Surveillance du sulfate de magnésium	Évaluation répétée des ROT, de la fréquence respiratoire et de la conscience. Signes d'hypermagnésémie (ROT diminués/abolis, FR < 10-12/min, troubles de conscience) → envisager l'arrêt de la perfusion et l'antagonisation par 1 g de gluconate de calcium IV.



7 — Menace d'accouchement prématuré (MAP)

Thème	Détail
Enjeu	1 ^{re} cause d'hospitalisation pendant la grossesse ; la morbi-mortalité néonatale est étroitement liée à l'âge gestationnel.
Diagnostic en régulation	Contractions utérines régulières et douloureuses entre la 24 ^e et la 36 ^e SA révolue. Facteurs de risque à rechercher : antécédent d'accouchement prématuré, grossesse multiple, infection maternelle, métrorragies, placenta prævia, malformation utérine, béance cervico-isthmique, hydramnios.
Transport	Décubitus latéral vers la maternité la plus proche de type adapté à l'âge gestationnel, sauf accouchement imminent justifiant l'envoi d'une équipe médicalisée.
Tocolyse préhospitalière	Exceptionnellement initiée, en concertation avec l'équipe obstétricale receveuse ; choix selon les disponibilités locales et les protocoles de réseau.
Contre-indications / non-indications au transport	Contre-indications : risque d'accouchement pendant le transport, souffrance fœtale aiguë patente. Non-indications médicales : TIU < 24 SA ou > 32 SA, transfert entre établissements de même type.
Éléments objectifs du TIU pour MAP	Longueur et ouverture du col par échographie endovaginale, recherche de la fibronectine. Vérifier la réalisation de la 1 ^{re} cure de corticothérapie de maturation pulmonaire fœtale avant tout transport. Réévaluation de la faisabilité du transport par l'équipe obstétricale au moment du départ.
Choix du tocolytique	Atosiban (antagoniste de l'ocytocine) : tocolytique de choix en préhospitalier (profil de tolérance favorable, pas d'effet secondaire grave notable). Inhibiteurs calciques : les plus utilisés actuellement bien que hors AMM — risques cardiovasculaires potentiellement graves (hypotension, OAP). Bêtamimétiques : effets indésirables hémodynamiques fréquents, potentiellement graves. Grossesse gémellaire : éviter les inhibiteurs calciques, bêtamimétiques contre-indiqués. Ne jamais associer plusieurs tocolytiques ; ne pas changer de tocolytique efficace lors d'un transfert médicalisé.
Surveillance pendant le transport	FC et PA systématiquement monitorées, avec rapport de surveillance écrit joint au dossier. Tococardiographie possible lors d'un transport de classe 3.

Tableau 4 — Choix du vecteur de transport selon l'état de la patiente (circulaire DHOS/01/2006/273) :

Classe	Situations cliniques
Classe 1 — ambulance simple	Rupture prématurée des membranes isolée ; MAP sans tocolyse IV (y compris grossesses gémellaires) ; MAP d'une grossesse simple avec tocolyse IV par antagoniste de l'ocytocine.
Classe 2 — transport infirmier interhospitalier (T2IH)	MAP d'une grossesse simple avec tocolyse IV (médicalisation à discuter au cas par cas selon le tocolytique) ; MAP gémellaire avec tocolyse IV par antagoniste de l'ocytocine (à défaut classe 1 si vecteur 2 indisponible).
Classe 3 — transport médicalisé (Smur)	MAP avec tocolyse IV : médicalisation à discuter selon le tocolytique ; MAP avec dilatation du col ≥ 4 cm et terme < 30 SA : à discuter avec le Samu en conférence téléphonique demandeur/receveur.

8 — Transferts in utero (TIU) interhospitaliers

Thème	Détail
Organisation	Régionale, intégrée aux réseaux de périnatalité (circulaire DHOS/01/2006/273 du 21/06/2006). Une cellule de périnatalité développe et applique les protocoles consensuels entre Samu, obstétriciens, néonatalogues, anesthésistes réanimateurs et sages-femmes, et recherche les places adaptées.
Indication	Inadéquation entre la structure d'hospitalisation et la pathologie maternelle/fœtale ; le bénéfice pour l'enfant est d'autant plus élevé que le terme est précoce. Si transport maternel pour pathologie non obstétricale, une surveillance obstétricale adaptée doit être possible dans la structure d'accueil.
Contre-indications fœtales	Anomalies du RCF significatives imposant une extraction sur place en urgence (engagement anticipé du Smur pédiatrique si terme < 32 SA ou poids estimé < 1500 g).
Contre-indications maternelles	Risque d'accouchement pendant le transport, suspicion d'HRP, HTA gravidique sévère non contrôlée, instabilité hémodynamique, placenta prævia avec métrorragies actives.



Thème	Détail
Règles de terme	Pas d'indication de TIU avant 24 SA (hors cause non liée à la grossesse) ; au-delà de 32 SA, le terme seul ne justifie pas un transfert vers un type supérieur ; pas d'indication médicale fœtale entre établissements de même type.
Décision pour MAP	L'équipe demandeuse évalue la longueur du col par échographie endovaginale. Décision fonction de 5 éléments : dilatation et longueur du col, contractions utérines, terme, type de l'établissement demandeur. À partir de 32 SA, une dilatation ≥ 4 cm est une contre-indication au transfert ; en deçà, l'opportunité se discute selon le type d'établissement et la durée de transport.
Orientation par terme	Type 2 : à partir de 32 SA avec poids fœtal estimé > 1500 g. Type 3 : menace d'accouchement très prématuré (24 SA à 31 SA + 6 j) ou poids estimé < 1500 g, grossesse triple.
Décision et modalités	Accord entre le médecin demandeur (présent auprès de la patiente) et le médecin receveur, puis avec le médecin régulateur du Samu et le médecin transporteur du Smur si le transport est médicalisé — les 3 classes de vecteur sont les mêmes que celles du Tableau 4 (rupture prématurée isolée, diabète gestationnel, cholestase, prééclampsie et métrorragies de prævia s'ajoutent aux critères MAP selon leur sévérité et la durée de transport). État clinique réévalué au départ pour confirmer la faisabilité.
Pendant le transport	Décubitus latéral ceinturé (prévention de la compression cave) ; dossier obstétrical accompagne systématiquement la patiente ; traçabilité écrite de la surveillance, des événements intercurrents et des traitements.

9 — Formation, évaluation des pratiques, réseaux (résumé)

Formation initiale puis continue recommandée pour tous les professionnels Samu/Smur aux urgences obstétricales préhospitalières (accouchement physiologique et situations complexes : procidence du cordon, dystocie des épaules, siège, hémorragies) — stages en maternité, supports multimédias, simulation sur mannequins. Programme d'évaluation des pratiques professionnelles selon une méthode HAS, avec objectifs de qualité en régulation (formation des permanenciers/régulateurs, items systématiques du compte rendu, indicateurs de délai) et en Smur (formation continue, liste et entretien du matériel dédié à l'accouchement, protocoles de renfort — sage-femme, Smur pédiatrique). Développement recommandé de réseaux périnataux régionaux associant obstétriciens, sages-femmes, néonatalogues/pédiatres, anesthésistes réanimateurs et Samu-Smur, avec protocoles partagés et transferts périnataux systématiquement régulés par le Samu.

Sources et traçabilité

Document source : « Urgences obstétricales extrahospitalières » — RFE SFAR/SFMU (avec CNGOF, Collège national des sages-femmes, GFRUP). Groupe de travail présidé par G. Bagou (SFAR/SFMU), secrétaire V. Hamel. 9 chapitres traités indépendamment. Recommandations validées au 3^e trimestre 2010.

Version : Ann Fr Anesth Reanim 2012;31:652-665. doi:10.1016/j.annfar.2012.06.001.

Méthodologie : méthode GRADE annoncée, cotation Delphi (2 tours), sans grade individuel 1+/2+/A/B/C — accord fort quasi systématique. Voir détail en page 1.

URL source : https://sfar.org/wp-content/uploads/2015/10/2_AFAR_Urgences-Obstetricals-Extrahospitalieres.pdf

Couverture : intégralité du contenu clinique actionnable des 9 chapitres, condensé en tableaux Thème/Détail (chapitres 2 à 8 en couverture complète ; chapitres 1 et 9, de nature organisationnelle/déontologique, résumés — voir texte intégral pour leur détail complet). 4 tableaux et 2 figures (algorithmes HPP et HTA) retranscrits intégralement.

Avertissement — document validé 2010 : cette fiche de synthèse indépendante reprend l'intégralité du contenu clinique actionnable du texte source, mais ne le remplace pas et n'est ni éditée ni validée par la SFAR ou la SFMU. Les seuils, posologies (notamment tocolytiques, antihypertenseurs, sulfate de magnésium) et protocoles de régulation/transport ayant pu évoluer depuis 2010, se référer à un avis spécialisé et aux recommandations actualisées avant toute décision thérapeutique.